



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : حنان محمود ابراهيم عربي
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : قليوب
العنوان : 00000
رقم البطاقة : 29502151403144 رقم التليفون : 01274773674
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-02-1995 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان محمود ابراهيم عربي National ID: 29502151403144	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



مطالعہ علمی و تاریخی خانقاہ حیدرآباد

قصان
مقصود الراجح عزاي مجاز
حجارة الخضري شي رشدي
شعر الكعبة لك - الطويل

2015

552961521

331473101A101A

٢٠٢١/٦ ٢٤٥٠٢١٥١٤٠٢١٤١
سنة
٢٠٢١/٦
٢٤٥٠٢١٥١٤٠٢١٤١
٢٠٢١/٦
٢٤٥٠٢١٥١٤٠٢١٤١



١١





MDT FORM 4 / 11 / 2025 G

Name	جان محمد ابراهيم	MRN	٢٠٩ / ٢٥
Age	30 yrs.	ID	٢٩٦٠٠١٥١٤٠٩١٤٤
Menopausal status		Phone	٥١٢٨١٤٦٦٢١٩
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	post op

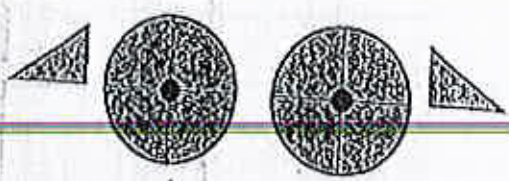
Clinical Data

BX: IDC G2 Focal DCIS R

ER: 818 PR: 818 HER2: 0 Ki67: 17%

Sonomammography:

Mets Workup:



TNM

Recommendations:

Post RT + SSN + AC + LO Pbx
Residual IDC G2 with focal DCIS
Free margins
LN: 3/11 with extracapsular extension
YPT1a YPN1
For possibility of Adj HT
Cis 2.2
Oginn
12/10/2025

MDT OUTCOME & PLAN

- ① AI + Zoladex
- ② Tamoxifen 16 months
- ③ PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr. [Signature]		[Signature]			

Patient Name	الاستاذ / د. محمد إبراهيم عيسى	Request No.	: 13007608
Patient No.	29502151403144	Request Date	: 08/09/2025
Path No.	2771/25	Verification Date	: 20/09/2025
Sex	Female	Financial Category	: لفئة الدولة - جوسفان روسي
Age	30 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc		Registered by	: Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer
Nature of the specimen: Right skin sparing mastectomy.

Gross Examination:

- Procedure: Right skin sparing mastectomy measured 24x20x5 cm with covering skin ellipse measured 14x6cm.
- Tumor extent: A grayish white tumour bed site
- Size: 6 x5x2 cm
- Skin Involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- Distance from margins: 0.7 cm away from deep margin.
- Axilla: Fibrofatty tissue piece measured 8x7x2 cm entangling 11 nodules up to 1.5x1 cm.

BLOCK DESIGNATION

1:6 TBS

7: Nipple

6: Deep margin

9: 11 ALNDS.

Grossing by: Dr. Heba El-Shafeey

Microscopic examination:

- Histological type: Residual Invasive duct carcinoma (cellularity 5%).
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G 2(3+2+2)
- Ductal carcinoma in situ: Wide, solid, cribriform, comedo types, low grade 25 %
- Lymphovascular emboli: Absent
- Microcalcification: Positive
- Skin Involvement: Free nipple and areola
- Lymph node Involvement: Positive L.Ns (3/11) with extracapsular extension, with perinodal infiltration, maximal tumor metastasis 1 cm.
- Resection Margins: Free deep margin, free superficial margin.

Verified by:

Dr. Heba Hasan

Printing Date: 28/09/2025 14:32:35

Page 1 of 2

Printing By: Mrs. Mayada Hegazy

حرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / د. خالد محمود إبراهيم
Patient No. : 29502151403144
Path No. : 2771/25
Sex : Female
Age : 30 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007608
Request Date : 08/09/2025
Verification Date : 20/09/2025
Financial Category : جوفاء روسي - تنكة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:
Right skin sparing mastectomy (post NACT)
Residual Invasive duct carcinoma grade 2, cellularity 5 % (Actual tumour 0.5x0.5 cm) with
focal ductal carcinoma insitu, wide, solid cribriform, comedo, low grade, 25 %.
• Free deep margin, free superficial margin
• Free nipple and areola
• Positive L.Ns (3/11) with extracapsular extension
• Stage : ypT1a, ypN1
• RCB : 2.759 / RCB Class, II
cellularity 5 %.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr. Heba El-Shafeey

Verified by:
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 28/09/2025 14:32:35

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt





Patient Name: Hanan Mahmoud Ibrahim Araby	Date : 20/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 30 Year(s)
Medical ID: 209/2025	Pat. ID: 98546

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Right breast mass, pathologically proven malignant for assessment

Patient had 1 cycle of NACT

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- Right breast UOQ segmental pleomorphic calcifications, measured 12.5x13cm, being 3.5cm from the nipple
- Complementary ultrasound showed right breast multiple irregular spiculated hypoechoic masses, the largest is seen at 10 o'clock measured 2.2x2.2cm.
- Left breast circumscribed oval hypoechoic mass, seen at 8 o'clock, measured 1x2cm
- Normal left skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LNs.
- Pathological right axillary less than 3 LNs, the largest is measured 2.5cm with cortical thickness 0.7cm.
- Free right infra and supra-clavicular regions

Opinion:

- Right breast UOQ extensive calcifications, with pathologically proven malignant masses (BIRADS 6)
- Left breast 8 o'clock probably benign mass (BIRADS 3)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

20/03/2025 3:02 PM



X-ray	UltraSound	Doppler	Digital Rad.	C.T.	MRI	Mammography
Patient Name:		HANAN MAHMOUD IBRAHIM			Age:	
Ref. Phys:					Date:	31/12/2024

CT CHEST, ABDOMEN & PELVIS SCAN WERE PERFORMED AFTER INTRA VENOUS CONTRAST INJECTION:

Known case of breast cancer.
No available surgical data/previous studies.

CHEST:

- Bilateral normal, comparable pulmonary parenchyma, with no intra alveolar, or interstitial focal lesion. In addition, a fairly distributed broncho pulmonary vascular channels.
- The mediastinal structures appear normal, including the great vessels. No soft tissue mass lesion, or lymphadenopathy.
- Free pleural sacs.
- Normal chest wall, regarding the bony and soft tissue components.

ABDOMEN & PELVIS:

- D7 shows small sclerotic lesion 6 mm based on its lower VEP.
- Left adnexal cystic lesion 3.8 cm.
- The liver is average size, regular margins, parenchyma shows homogeneous attenuation pattern, in either lobe. No structural defect or masses are noted. No intra or extra hepatic biliary radicals dilatation.
- Kidneys are average size, regular smooth margins, of homogeneous attenuation pattern, and adequate excretory function. No focal mass lesion.
- Spleen, pancreas, supra renal glands are average size, regular margins, with homogeneous attenuation pattern of the parenchyma. No focal mass lesion.
- No para aortic, or retro peritoneal lymphadenopathy, or mass lesion.
- No ascites, or localized collection.
- Average size of the uterus, with regular margins, and homogeneous attenuation pattern. No focal mass lesion.
- The bladder is average distension, regular wall. No focal lesion.

CONCLUSION:

- D7 small well-defined sclerotic lesion likely bone island, for follow up.
- Left adnexal cystic lesion.

M.S

Much Obligated
Dr. Anas El Hadary M.Sc

Radiology Department

Al - Hussein Hospital - El Darasa - Cairo
Tel : 25105628 - 25109140 Fax: 25104146

مستشفى الحسين الجامعي - الدراسة - القاهرة
تليفون: ٢٥١٠٥٦٢٨ - ٢٥١٠٩١٤٠ فاكس: ٢٥١٠٤١٤٦